

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma.} Asamblea
Legislativa

3^{ra.} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 842

INFORME NEGATIVO CONJUNTO

30 de enero de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO

Las Comisiones de Salud y de Hacienda, Presupuesto y PROMESA del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración del **Proyecto del Senado 842**, no recomiendan a este Alto Cuerpo su aprobación.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El **Proyecto del Senado 842** propone crear la Cuenta Nacional de Salud, con el fin de establecer un sistema contable para organizar, recopilar y presentar información sobre el gasto y financiamiento de los sistemas de salud en Puerto Rico; y para establecer otras disposiciones complementarias.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

Según se desprende de la Exposición de Motivos de la medida, el modelo de financiamiento y gastos del actual sistema de salud puertorriqueño no permite el acceso oportuno y equitativo a servicios de salud de calidad para todas las personas. En los últimos años, Puerto Rico ha sido uno de los países del mundo donde más se gasta en servicios de salud en proporción al tamaño de su economía. Según datos de la Junta de Planificación, del 2015 al 2024, el gasto de consumo personal en servicios de salud creció de un 12.1% a un 28.3%, como proporción del Producto Bruto Interno (PIB) del país. No obstante, la atención, gastos y recursos han estado dirigidos desproporcionadamente al

aspecto reactivo y curativo de los servicios de salud, que es el más costoso. Como resultado, tenemos una población con una mayor expectativa de vida al nacer, pero con una alta prevalencia de enfermedades crónicas y condiciones relacionadas con el envejecimiento que ocasionan una alta morbilidad, pérdida de calidad de vida, precarización económica y mayor mortalidad, especialmente en la población que vive bajo los niveles de pobreza.

Plantearon los autores que el actual modelo de financiamiento y gastos solamente ha beneficiado al sector privado de las aseguradoras, no al pueblo. Según un informe preparado por la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS), para el año 2022, la distribución porcentual de la población asegurada en Puerto Rico por tipos de planes médicos fue la siguiente: 21.3% en Medicare, 45.6% en Plan Vital, y 33.1% en planes médicos privados grupales o individuales. En resumen, casi un 67% de la población asegurada y un 83.2% de las primas están bajo los programas de Vital y Medicare, que se financian a través de fondos públicos estatales y federales. El sistema actual permitió que, entre 2015 y 2024, la industria de seguros de salud en Puerto Rico destinara más de \$11,800 millones a gastos administrativos; recursos que no se invirtieron directamente en servicios médicos para sus asegurados, lo que contribuyó al aumento de sus ganancias netas, acumulando cientos de millones de dólares.

Expusieron, además, que mientras las aseguradoras se enriquecen con el dinero del pueblo, tenemos una población que vive más, pero enferma y sin calidad de vida. Este escenario es insostenible a mediano y largo plazo desde el punto de vista salubrista y económico. Cuando se le añade el inminente recorte de fondos federales con los que se financia parte de nuestro sistema de salud, más que nunca urge transformarlo con políticas que aseguren decisiones informadas con el objetivo de garantizar un sistema de salud sostenible desde una gobernanza transparente y ágil. Un paso esencial para lograr este objetivo es la institucionalización de un sistema de evaluación y monitoreo continuo del financiamiento y gastos de salud.

También se menciona en la Exposición de Motivos que las Cuentas Nacionales de Salud constituyen una herramienta validada para medir el gasto en salud. Es un sistema contable a nivel agregado diseñado para organizar, recopilar y presentar información sobre el gasto y financiamiento de los sistemas de salud. La calidad de los resultados de las Cuentas dependerá de la recopilación de datos pertinentes y confiables del sector público y del privado desde un escenario institucional estable.

Por lo anterior, los autores de la pieza legislativa proponen establecer como política pública la transparencia y la responsabilidad en el financiamiento y seguimiento de los recursos del sistema de salud mediante la estimación anual de una Cuenta Nacional de Salud donde el Departamento de Salud tenga una unidad dedicada solamente a producir anualmente esta Cuenta en colaboración y coordinación con la academia, el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico y demás sectores con interés en las estadísticas de salud. Como parte de sus obligaciones, el Departamento llevará a cabo actividades complementarias para la divulgación anual y proactiva de los resultados de la Cuenta a los responsables de formular políticas públicas y al público en general.

ALCANCE DEL INFORME

Como parte del proceso de análisis y evaluación del **P. del S. 828**, las Honorables Comisiones de Salud y de Hacienda, Presupuesto y PROMESA del Senado solicitaron los comentarios sobre la medida a diversos componentes gubernamentales y no gubernamentales. Los memoriales recibidos y utilizados para el análisis de esta pieza legislativa son: el Departamento de Salud (DS), la Administración de Seguros de Salud (ASES) y el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico.

Igualmente, se solicitaron los comentarios a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) y la Universidad de Puerto Rico (UPR); no obstante, al momento de redactar este Informe, estos no han remitido los mismos.

A continuación, presentaremos un resumen de los argumentos y comentarios esbozados por las diferentes agencias y entidades consultadas durante el proceso de evaluación de la medida en referencia.

DEPARTAMENTO DE SALUD (DS)

Luego de examinar la pieza legislativa de referencia, el **Departamento de Salud (DS)** presentó su memorial explicativo por conducto de su Secretario, Victor M. Ramos Otero, expresándose en contra de la aprobación de la medida.

El Departamento recordó su origen constitucional y legal, al haber sido creado mediante la Ley Núm. 81 de 14 de marzo de 1912 y elevado posteriormente a rango constitucional

en 1952, lo que le confirió el deber indelegable de atender todas las cuestiones relacionadas con la salud pública en Puerto Rico, incluyendo la prevención y el control de enfermedades prevalentes y epidémicas. Indicó que, en cumplimiento con la política pública vigente, la Agencia ha promovido el acceso universal a servicios de salud de calidad, mediante sus distintas secretarías auxiliares, oficinas y programas, reafirmando su rol rector dentro del sistema de salud de la Isla.

En cuanto al contenido sustantivo de la medida, señaló que, tras un análisis detallado, identificó limitaciones significativas para la implementación de la medida. Sostuvo que, aunque la medida, tiene un objetivo loable, no se especifica un presupuesto concreto para su implementación. Resaltó que, incluso, aunque contara con los recursos necesarios para cumplir con lo estipulado, necesitaría la autorización del Departamento de Hacienda, que es el administrador del Sistema Financiero PRIFAS, utilizado por la mayoría de las agencias gubernamentales.

Aclaró que, aunque el Departamento de Salud utiliza un sistema diferente, este se conecta con PRIFAS. Además, explicó que la política pública actual impulsa la transición de todo el Gobierno hacia un sistema financiero integrado, conocido como “Enterprise Resource Planning” o “ERP”.

El Departamento de Salud concluyó reiteró no endosar la medida y reafirmó su disposición para contribuir con su experiencia en futuros proyectos que fortalezcan la salud integral de la población

ADMINISTRACIÓN DE SEGUROS DE SALUD (ASES)

Estas Ilustres Comisiones tuvieron la oportunidad de examinar los comentarios presentados por la **Administración de Seguros de Salud (ASES)** quien presentó su memorial explicativo por conducto de su Director Ejecutivo, Lcdo. Carlos A. Santiago Rosario expresándose en contra de la aprobación de la medida.

Reconoció los esfuerzos de la Asamblea Legislativa y de la Comisión de Salud para atender un asunto de alto interés público, dada la relevancia del sistema de salud para aproximadamente 1.3 millones de beneficiarios en Puerto Rico. En cuanto a su trasfondo institucional, la ASES explicó que fue creada mediante la Ley Núm.72 de 7 de septiembre de 1993, según enmendada, como una corporación pública con personalidad jurídica independiente, encargada de administrar el Plan de Salud del Gobierno de Puerto Rico,

conocido como Plan Vital. Asimismo, indicó que dicho programa se financia con fondos estatales y federales, y por lo que ejerce una responsabilidad fiduciaria sobre la administración eficiente de estos recursos.

ASES señaló que el Plan Vital representa una proporción significativa del gasto público en salud, al cubrir cerca del 67 % de la población asegurada y al 83.2 % de las primas, con un costo aproximado de cinco mil millones de dólares anuales. Reconoció la necesidad de contar con herramientas de información robustas para atender el impacto fiscal del programa y el aumento en la prevalencia de enfermedades crónicas.

De igual forma, destacó que, en coordinación con el Departamento de Salud y el Programa Medicaid, se ha desarrollado e implementado el sistema Puerto Rico Medicaid Management Information System (PR-MMIS), el cual permite el registro, validación y pago de reclamaciones, el monitoreo fiscal y presupuestario y la generación de informes contables y estadísticos necesarios para la toma de decisiones.

Acentuó, que el PR-MMIS ya cumple con objetivos similares a los propuestos en el Proyecto del Senado 842, por lo que alertó que redirigir esfuerzos hacia la creación de un sistema adicional podría resultar redundante y perjudicial para los logros alcanzados.

ASES concluyó su ponencia reiterando apoyar la aprobación del Proyecto del Senado 842, al entender que la medida duplicaba funciones ya existentes.

INSTITUTO DE ESTADÍSTICAS DE PUERTO RICO

Durante el proceso de evaluación del Proyecto del Senado 842, las Comisiones de Salud y de Hacienda, Presupuesto y PROMESA del Senado examinaron el memorial explicativo sometido por el **Instituto de Estadísticas de Puerto Rico**, por conducto de su Director Ejecutivo, Dr. Orville M. Disdier Flores. En el mismo, expuso de manera detallada su posición institucional favorable a la medida, así como múltiples recomendaciones técnicas dirigidas a fortalecer su implementación efectiva.

Según indicó, la medida responde a la necesidad apremiante de transformar el modelo vigente de financiamiento del sistema de salud, el cual evidenció un crecimiento sustancial del gasto en servicios de salud de un 12.1% a un 28.3% del Producto Interno Bruto entre los años 2015 y 2024 sin que dicho aumento se traduzca proporcionalmente en mejores resultados de salud para la población.

A tales efectos, el Instituto manifestó que la institucionalización de una Cuenta Nacional de Salud constituye una herramienta esencial para la gobernanza basada en evidencia, al permitir un monitoreo continuo, sistemático y confiable de los flujos financieros del sistema de salud.

Destacó como acertada la decisión legislativa de fundamentar la Cuenta en la metodología internacionalmente validada por la Organización Mundial de la Salud, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y la Comisión Europea, conocida como el Sistema de Cuentas de Salud 2011 (SHA 2011).

Asimismo, el Instituto resaltó que el Proyecto incorporó elementos estructurales fundamentales para su viabilidad técnica, entre los cuales destacó la creación de una Unidad de Cuenta Nacional de Salud con carácter permanente dentro del Departamento de Salud. De igual forma, valoró positivamente la facultad otorgada al Departamento de Salud para requerir información del sector público y privado, así como la obligación de divulgar anualmente los resultados de la Cuenta Nacional de Salud.

Sin embargo, identificó áreas que, a su entender, requieren fortalecimiento mediante enmiendas técnicas, particularmente en lo relacionado con la definición de roles interagenciales, el establecimiento de plazos de implementación, los estándares de calidad de datos, la protección de información confidencial y la asignación presupuestaria.

En síntesis, el Instituto concluyó que la aprobación del Proyecto del Senado 842 representaría un avance significativo hacia un sistema de salud más transparente, eficiente y equitativo, reiterando su disposición de colaborar con esta Honorable Comisión y con las entidades concernidas para asegurar la implementación efectiva de la medida.

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES

Luego de un examen detenido y ponderado del **Proyecto del Senado 842**, así como del análisis de los memoriales sometidos por el Departamento de Salud, la Administración de Seguros de Salud (ASES) y el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, las Comisiones

de Salud y de Hacienda, Presupuesto y PROMESA del Senado de Puerto Rico realizaron una evaluación integral del alcance, viabilidad y pertinencia de la medida.

Aunque las Comisiones consideran que el Proyecto del Senado 842 persigue un objetivo legítimo y loable, al procurar establecer un mecanismo de transparencia y rendición de cuentas sobre el financiamiento y el gasto del sistema de salud en Puerto Rico mediante la creación de una Cuenta Nacional de Salud, no puede recomendar favorablemente la aprobación de la pieza legislativa toda vez que, del análisis del marco institucional vigente surgió que el Gobierno de Puerto Rico ya cuenta con estructuras operacionales y sistemas tecnológicos robustos para la recopilación, validación y monitoreo del gasto en salud, particularmente a través del Plan de Salud del Gobierno y el Programa Medicaid.

En ese sentido, las Comisiones encontraron altamente persuasivos los señalamientos presentados por la Administración de Seguros de Salud (ASES), entidad con responsabilidad fiduciaria sobre el Plan Vital, la cual evidenció que el sistema Puerto Rico Medicaid Management Information System (PR-MMIS) ya cumple funciones sustancialmente similares a las que se pretendieron implantar mediante la medida legislativa. Dicho sistema permite el registro detallado de reclamaciones, el monitoreo fiscal y presupuestario, así como la generación de informes contables y estadísticos confiables para la toma de decisiones públicas. A juicio de las Comisiones, la creación de una estructura paralela podría provocar una duplicación innecesaria de esfuerzos, con el consecuente uso ineficiente de fondos públicos.

Asimismo, las Comisiones observaron que el Proyecto del Senado 842 no delimita con precisión la interacción entre la Cuenta Nacional de Salud propuesta y los sistemas ya existentes, lo cual generaría incertidumbre jurídica y operacional. Esta falta de definición podría traducirse en cargas administrativas adicionales tanto para las agencias gubernamentales como para el sector privado, afectando la agilidad y eficiencia del sistema de salud.

Por otro lado, si bien el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico expresó su respaldo conceptual a la medida y reconoció sus fortalezas metodológicas, dicho apoyo estuvo condicionado a la adopción de múltiples enmiendas sustantivas. Entre estas, se destacaron la necesidad de clarificar los roles interagenciales, establecer plazos de implementación razonables, definir estándares de calidad de datos, garantizar la protección de información confidencial y asegurar una asignación presupuestaria

adecuada y recurrente. A juicio de las Comisiones, estas recomendaciones evidencian que la medida carece de elementos esenciales para su implementación efectiva según actualmente redactada.

De igual forma, las Comisiones consideran de particular preocupación, que el proyecto imponga nuevas obligaciones operacionales al Departamento de Salud sin identificar una fuente de financiamiento específica ni recurrente, ni evaluar adecuadamente su impacto fiscal. Esta omisión resulta especialmente relevante en el contexto actual de restricciones presupuestarias y de alta dependencia de fondos federales para el sostenimiento del sistema de salud en Puerto Rico.

En vista de lo anterior, y tras sopesar los beneficios potenciales frente a los riesgos administrativos, fiscales y operacionales identificados, las Comisiones de Salud y de Hacienda, Presupuesto y PROMESA concluyen que el Proyecto del Senado 842 no resulta viable en su forma actual. Por consiguiente, no se recomienda aprobar la medida.

CONCLUSIÓN

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, las Comisiones de Salud y de Hacienda, Presupuesto y PROMESA del Senado de Puerto Rico, luego de la consideración correspondiente, tienen a bien someter a este Alto Cuerpo su **Informe Negativo Conjunto** sobre el **Proyecto del Senado 842**, No Recomendando su aprobación.

Respetuosamente sometido,

Juan Oscar Morales Rodríguez
Presidente
Comisión de Salud

Migdalia Padilla Alvelo
Presidenta
Comisión de Hacienda,
Presupuesto y PROMESA